جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : الهام احمد حسين احمد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** رمسيس **العنوان :** ===
رقم البطاقة : 28006012107742 **رقم التليفون :** 01141478273 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-06-1980 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: الهام احمد حسين احمد
National ID: 28006012107742

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bone scintigraphy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية

الهام

احمد حسين احمد

٢٧ش محمد حسن ش البصراوى

امبابة - الجيزه

٢٨٠٠٦٠١٢١٠٧٧٤٢

LP0055248



٢٠٢٦/٠١

٢٨٠٠٦٠١٢١٠٧٧٤٢

حاصله على دبلوم تجاره

انثى مسلمة

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠١/٢٥



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM 21 / 8 / 2025 G

Name	إلهام أحمد حامد	MRN	٢٠٠٥٠٢٤١
Age	45	ID	٢٨٠٠٦٠٢٤١٠٧٧ ٢
Menopausal status	premenopausal	Phone	٠١١٤٦٤٥٨٧٢
NRS SCORE		Marital status	Divorced
BMI		Family history	ve. brc. gastric
CO morbidity	-ve	REASON OF MDT	Δ Dx case.

Clinical Data

BX: IDC II

ER:	PR:	HER 2:	KI67:
6/8	6/8	0	5%

R L



nipple retraction

cTNM 4b1 2

Sonomammography:

Mets Workup: CT3 CAP
① - Diffuse bone Mets ?
② - bilateral axillary, Inguinal LN. lesion

Recommendations:

For PET/CT
Then RMDT
review for sca By Rad
→ Multiple sclerotic

MDT OUTCOME & PLAN

Δ bone
Meanwhile sdt Aromex + Zoladex
premeno-status

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: الهام احمد حسين **MR. :** 4608	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

IDC ER 8/8 PR 8/8 HER 0 KI67 5% CT4b n2 received AI, ZOLADEX 3 MS BONE SCAN FREE

CT CAP TO BE COMPARED TO LAST CT scan and verify nature of bony lesion

MBC TO BONE ARAMIDEX +ZOLADEX +SUPPORTIVE*3M NEXT VISIT :27/10/2026

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : حنان عزت شفيق تاودروس

يعتمد ,

Patient ID: 85375	Patient Name English: Eiham Ahmed Hussein Ahmed
Age: 45 y	2025/07/06 11:48:47 AM :Report Date

Women's Health Outreach Program
Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: Left breast lump.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- Heterogeneously dense fibroglandular parenchyma (ACR C) that may obscure small lesions.
- LIQ retroareolar architectural distortion, and LIQ posterior third focal asymmetry. Associated with nipple retraction.
- Ultrasound demonstrated LIQ, posterior third, 7:00 heterogeneous hypoechoic parenchyma, measuring 12x8mm. The whole breast anterior and middle third is heterogeneously hypoechoic infiltrated.
- The nipple is retracted with the retroareolar distorted parenchyma.
- Pathological axillary LNs seen at level 1, one of them is infiltrated, measuring about 17x8mm.
- No pathological LNs seen at level 2,3 or supraclavicular region.

Right breast

- Heterogeneously dense fibroglandular parenchyma (ACR C) that may obscure small lesions.
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Indeterminate axillary LN, the largest measures about 20x8 mm with 4.5mm focal cortical thickening.

Impression:

- Left breast locally advanced malignant looking process with ipsilateral pathological LNs (BIRADS 5)
- Right breast (BIRADS 2): Fibroadenosis with indeterminate axillary LN.

Recommendations:

US guided core biopsy done at same sitting for histopathological correlation.

Dr.Ghada Khaled

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

NHTMRI

قسم البثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: الهام احمد حسين

Age: 45years

Sex: Female

Request type: مباشره
Hospital no:
Department: صحة المرأة
Referred by: د/علاء خلف
Nature of specimen: TRU CUT BIOPSY
Clinical diagnosis: Left Breast mass

Sub request type:
Pathology No.: 268-2025
Date of Result:
Receiving date: 6/7/2025
I.D. Number: 28006012107742

Gross pathology :

Multiple grayish white tissue cores up to 0.5cm long, totally submitted.

Microscopic picture:

Section examined revealed breast core tissue showed clusters,cord, tubules, nest and cribriform pattern of anaplastic ductal cells with single anaplastic cells showed moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules dispersed among desmoplastic stroma with mild lymphocytic response and focal area of hemorrhage.

Immunohistochemical Result

ER: Positive Strong nuclear staining in 30% of tumor cells (Allred Score 6/8).
PR: Positive strong nuclear staining of 30% of tumor cells (Allred Score6/8).
Her2: No membranous staining of tumor cells (Score 0).
Ki67: Positive nuclear staining of <5% of tumor cells.

Diagnosis:

Invasive mammary carcinoma.
(ER 6/8, PR 6/8, Her2 Score 0, Ki67<5%)

Signature:
Dr. Nermine Nbil.M.D
Dr.Mona Mohamed. M.D

Pathology Lab. Manager

Nermine Nabil, M.D

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

NILE SCAN & LABS

مركز النيل للأشعة والتحاليل

Name: Eltaan Abo Ed Hussein Ahmed	Date: 27-08-2025 08:38
Branch: Nasr City	Medical No: 184600
Ref Physician: Costal Rosch Hospital	In Company:

Whole body PET/CT EXAMINATION:

Clinical History:

- 45-year-old female patient with pathologically proven left breast cancer.
- PET/CT requested for assessment.

Technique:

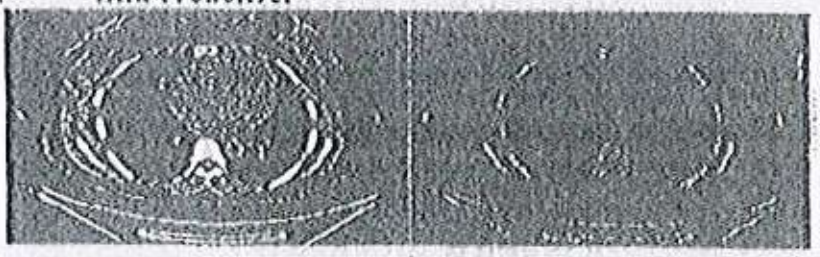
- For the aforementioned patient we have done a total body PET scan one hour after IV injection of 370 MBq of 18 F-FDG. MSCT was performed using GE Discovery IQ simultaneously and used for attenuation correction, anatomical localization and diagnosis.

Report

Hepatic reference activity: 4.8

Left breast retracted nipple with underlying retro-areolar dense parenchymatous tissue showing low grade FDG activity of SUVmax~2.

- Associated with multiple left sided axillary LNs largest is seen measuring about 1.6 cm showing low grade FDG activity of SUVmax~1.1.
- Few non-FDG avid prominent right sided axillary LNs with preserved fatty hila ?reactive.



Widespread non-FDG avid sclerotic osseous changes are seen involving the spine, bilateral clavicles, the sternum, bilateral ribs, the sacrum, bilateral iliac bones, acetabula, ischial bones and bilateral femoral necks/trochanters, possibly due to dronate/bisphosphonate therapy.



PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

NILE
SCAN & LABS

مركز النيل للأشعة والتحاليل

Name: Ahmed Hussein Ahmed	Date: 27.08.2025 08:38
Branch: Nasr City	Medical No: 184600
Ref Physician: Gastro Rosh Hospital	Ins Company:

Head and Neck:

- No hypermetabolic cervical lymphadenopathy could be detected.
- Physiologic FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands, and larynx.
- The brain shows uniform tracer distribution with NO hypermetabolic focal lesions.

Chest:

- No hypermetabolic mediastinal lymphadenopathy.
- No FDG avid lung nodules or masses.
- There are no active pleural or pericardial abnormalities.
- Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

- No hypermetabolic abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- Physiologic diffuse FDG uptake is seen over average sized liver with homogenous parenchymatous texture. No FDG avid focal lesions detected.
- Physiologic diffuse FDG uptake is seen over average size spleen with homogenous parenchymal texture and no FDG avid focal lesions seen.
- The pancreas shows normal FDG avidity.
- There are no active adrenal nodules.
- Right renal cortical cyst.
- Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder.
- Non-FDG avid right adnexal cyst measuring about 4x3 cm for TVUS correlation.

Conclusion:

PET-CT for a case of left breast cancer shows:

- Low grade FDG avid left breast retracted nipple with dense retro-areolar parenchymal tissue, associated with low grade FDG avid ipsilateral LNs.
- Widespread non-FDG avid osseous sclerotic lesions, likely due to dronate/bisphosphonate therapy.

Thank you for referral

Walid Omar, MD
Prof. of nuclear medicine.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name: Elham Ahmed Hussein	Date: 10/08/2025
Exam: CT CARE (CT Chest Abd Pelvis)	Age: 45 Year(s)
Medical ID: 2141/2025	Rad ID: 110901

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:
Known case of breast cancer with no previous films available for comparison, revealed:

I: CHEST:

- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.
- Multiple bilateral axillary lymph nodes are noted largest measuring 1.4 cm along its shortest axis on the right side.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Effacement and smudging of the central upper abdominal fat planes with misty mesentery sign associated with multiple subcentimetric lymph nodes.
- Enlarged liver size showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesions or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Small right renal lower cortical cyst measuring 2cm.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- No ascites.
- Multiple diffusely scattered sclerotic foci seen through the examined axial and peripheral skeleton.
- Multiple bilateral inguinal lymph nodes are noted largest measuring 1.5 cm along its shortest axis on the left side.

Opinion:

- Multiple bilateral axillary and inguinal enlarged lymph nodes as described for PETCT correlation.
- Diffuse sclerotic foci in the examined skeleton likely metastatic.
- Smudged central upper abdominal fat planes with multiple subcentimetric lymph nodes likely representing mesenteric panniculitis.

Dr Zeyad El-Sayed,FEBR

Signature Dr.Mohamed Hassan
17/08/2025 8:06 PM

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]